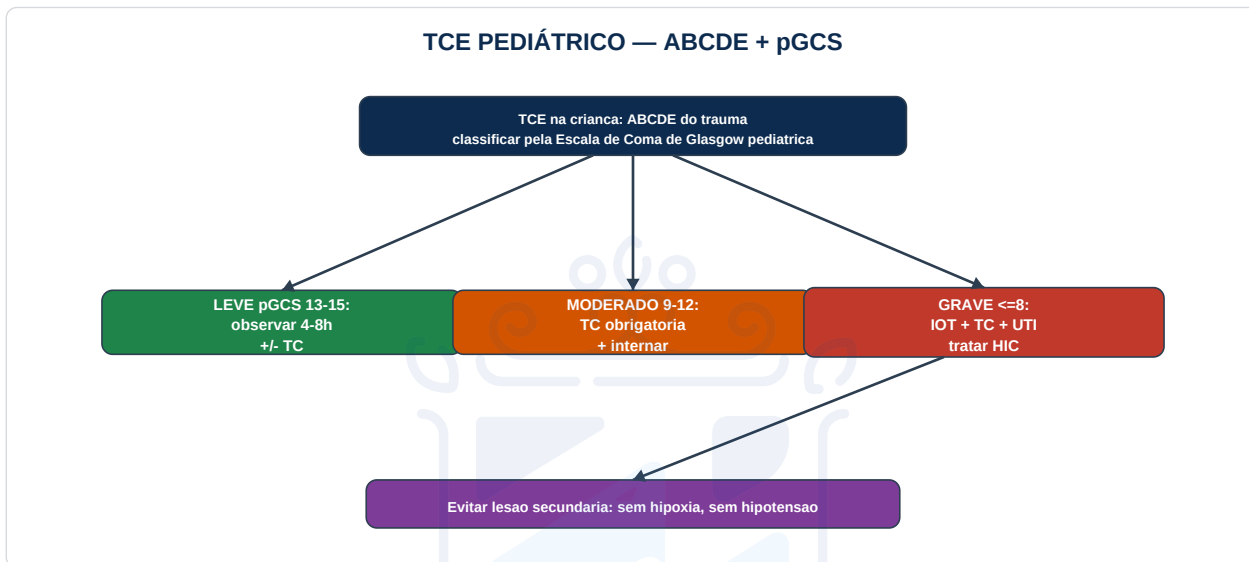


TCE NA INFÂNCIA — pGCS GUIA A CONDUTA

FLUXOGRAMA — GRAVIDADE GUIA TUDO



DEFINIÇÃO E PARTICULARIDADES

POR QUE A CRIANÇA É DIFERENTE

- Lesão das estruturas da cabeça por força mecânica externa; incidência bimodal (< 4 anos e adolescência), predomínio masculino
- Lesão PRIMÁRIA (no impacto) x SECUNDÁRIA (hipóxia, hipotensão, edema, HIC) — esta é EVITÁVEL e o alvo do tratamento
- Crânio mais fino, cabeça proporcionalmente maior, maior conteúdo de água -> mais vulnerável à lesão secundária
- < 2 anos: quedas e MAUS-TRATOS (síndrome do bebê sacudido) — alta suspeição se história inconsistente
- Avaliar sinais de fratura de base: Battle, guaxinim, rinorreia/otorreia de LCR

RED FLAGS — INDICAM TC / GRAVIDADE

SINAIS DE ALARME

- Rebaixamento (pGCS < 15), perda de consciência prolongada, amnésia, convulsão pós-traumática
- Vômitos persistentes, cefaleia progressiva, irritabilidade/letargia anormal
- Déficit focal, assimetria pupilar, fontanela abaulada (lactente)
- Sinais de fratura de base de crânio; afundamento/fratura palpável; hematoma de couro cabeludo em lactente
- Mecanismo de alta energia; suspeita de maus-tratos (história incompatível)

EXAME COMPLEMENTAR

TC DE CRÂNIO É O EXAME DE ESCOLHA

- TC de crânio SEM contraste: padrão para lesão intracraniana; RX de crânio tem valor limitado
- TCE leve sem critérios de risco (baixo risco): observação clínica 4-8h, em geral SEM TC
- Risco intermediário: decisão individualizada (TC x observação — achados múltiplos, piora durante a observação, preferência dos pais)
- Moderado/grave: TC obrigatória; glicemia capilar em todo rebaixamento
- Diferencial do rebaixamento: hipoglicemia, intoxicação, infecção do SNC, crise não traumática

MANEJO POR GRAVIDADE

Rx LEVE / MODERADO / GRAVE

LEVE (pGCS 13-15): observação 4-8h; alta se pGCS 15, exame normal, TC normal (se feita) e responsáveis orientados sobre sinais de alerta

MODERADO (9-12): internar + TC; normotermia, cabeceira 30°, evitar hipóxia/hipotensão; neurocirurgia se lesão na TC
GRAVE (≤ 8): IOT, ventilação (evitar hipóxia/hipercapnia), estabilidade hemodinâmica; monitorizar PIC/PPC (PIC < 22 mmHg)

Controle de HIC: cabeceira 30° neutra, sedoanalgesia (fentanil/midazolam/cetamina)

Terapia hiperosmolar: Manitol 20% 0,5-1 g/kg EV (osm < 320) OU salina 3% 1-3 mL/kg EV (Na 155-160)

Hiperventilação só na herniação iminente (PaCO₂ 25-30, transitória); anticonvulsivante (fenitoína/levetiracetam) se alto risco

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ ALTA (TCE leve): pGCS 15, exame neurológico normal, TC normal (se realizada), sem vômitos persistentes, responsável confiável e orientado
- ☐ INTERNAR: TCE moderado/grave, alteração na TC, vômitos persistentes, convulsão, suspeita de maus-tratos, impossibilidade de observação domiciliar
- ☐ UTI + neurocirurgia: pGCS ≤ 8 , lesão com efeito de massa, HIC
- ☐ Orientações de alta: repouso relativo, evitar impacto, dieta leve
- ☐ Retorno IMEDIATO: vômitos repetidos, sonolência excessiva, cefaleia intensa, convulsão, déficit, irritabilidade, saída de líquido pelo nariz/ouvido

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos/ ____ kg; TCE por ____ (mecanismo); pGCS ____; pupilas ____; déficit ____.
- TC: ____ (lesão/efeito de massa?); vômitos ____; convulsão ____; suspeita de maus-tratos: ____.
- Condutas: ABCDE, IOT ____, cabeceira 30°, sedoanalgesia, hiperosmolar (manitol/salina 3%) ____, anticonvulsivante ____.
- Solicito UTI pediátrica + neurocirurgia; transporte evitando hipóxia/hipotensão. Notificar maus-tratos se suspeita.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Lactente de 18 meses com TCE, pGCS 7, pupila anisocórica. Qual a conduta imediata?

- A) Observação clínica por 6 horas
- B) ABCDE com intubação orotraqueal, TC de crânio e medidas para HIC (cabeceira 30°, terapia hiperosmolar), UTI
- C) Alta com orientações
- D) Apenas analgesia oral
- E) RX de crânio e reavaliação ambulatorial

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame de escolha para avaliar lesão intracraniana no TCE pediátrico?

- A) Radiografia de crânio
- B) Tomografia computadorizada de crânio sem contraste
- C) Ultrassonografia transfontanela de rotina
- D) Ressonância magnética em todos
- E) Eletroencefalograma

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

No TCE grave, o principal objetivo do tratamento é:

- A) Reverter a lesão primária
- B) Prevenir a lesão secundária (evitar hipóxia, hipotensão e HIC)
- C) Indicar corticoide de rotina
- D) Hiperventilação prolongada
- E) Restrição hídrica agressiva

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Lactente < 2 anos com fratura de crânio e história inconsistente com o trauma relatado. O que deve ser considerado?

- A) Quadro benigno, alta direta
- B) Suspeita de maus-tratos (síndrome do bebê sacudido) — investigar e notificar
- C) Apenas analgesia
- D) Doença óssea fisiológica da idade
- E) Convulsão febril

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual opção é correta sobre a terapia hiperosmolar para HIC no TCE pediátrico grave?

- A) Manitol 20% 0,5-1 g/kg EV ou salina hipertônica 3% 1-3 mL/kg EV
- B) Soro glicosado a 5% em bolus
- C) Restrição total de líquidos
- D) Furosemida isolada como primeira escolha
- E) Solução hipotônica para reduzir o sódio

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

pGCS ≤ 8 com anisocoria indica TCE grave com possível HIC/herniação: ABCDE com IOT (proteção de via aérea), TC de crânio e medidas anti-HIC (cabeceira 30°, sedoanalgesia, terapia hiperosmolar), em UTI, com avaliação neurocirúrgica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de crânio sem contraste é o exame de escolha para lesões intracranianas; a radiografia de crânio tem valor limitado e não substitui a TC.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O objetivo é prevenir a lesão secundária — evitar hipóxia, hipotensão e controlar a HIC — pois a lesão primária já ocorreu no momento do trauma. Corticoide não é indicado no TCE.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Fratura de crânio em lactente < 2 anos com história inconsistente deve levantar suspeita de maus-tratos (incluindo síndrome do bebê sacudido), com investigação (série óssea) e notificação obrigatória.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

A terapia hiperosmolar para HIC usa Manitol 20% (0,5-1 g/kg EV, osm < 320 mOsm/L) ou salina hipertônica 3% (1-3 mL/kg EV, Na-alvo 155-160 mEq/L). Evitam-se soluções hipotônicas.

SM24
Suporte ao Plantão Médico